Manual de organización políticas y responsabilidades del consultorio

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para manual de organización políticas y responsabilidades del consultorio, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Objetivo y estructura

Definir responsabilidades reales y evitar vacíos de decisión. Identificar tipo de prestador, sede, horarios y personal existente. Para profesional independiente un organigrama puede tener una persona con funciones diferenciadas; no inventar comités o cargos.

Asignación

Asignar atención clínica, consentimiento, archivo, calidad, seguridad, limpieza, residuos, mantenimiento y respuesta a emergencias. Registrar suplencias y servicios externos contratados. Cuando una persona cumple varias funciones, separar verificaciones críticas y dejar evidencia de revisión.

Políticas

Adoptar acceso digno, confidencialidad, información clara, seguridad, uso responsable de recursos y atención de quejas. Comunicar por medios accesibles. Revisar que las políticas se reflejen en conducta, recursos y registros, no solamente en carteles.

Control

Evaluar disponibilidad y competencia del responsable antes de cambios de oferta. Resolver conflictos de interés y fallas de supervisión. Mantener registros de decisiones y comunicación interna, sin actas ficticias ni firmas prellenadas.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Aplicabilidad y responsables

Relacionar este documento con sede, servicio, modalidad y tareas realmente realizadas. Designar ejecutor, suplente y revisor por nombre/rol; comprobar competencia y recursos. Si No aplica, justificar con oferta real y criterio normativo, sin utilizarlo para ocultar una actividad que sí se ejecuta.

Preparación del proceso

Reunir información y soportes descritos en sus secciones: documentos vigentes, equipos o productos identificados, condiciones de sede y proveedores verificados. Revisar fechas, integridad y coherencia entre el soporte y la operación; una certificación de otro equipo o profesional no es intercambiable.

Ejecución y evidencia

Registrar actividades reales con fecha, responsable, resultado y ubicación del soporte. Diferenciar programación de ejecución y solicitud de respuesta recibida. Mantener versión de origen, trazabilidad de cambios y acceso apropiado; no completar registros retrospectivamente sin señalar adenda.

Hallazgos y cierre

Describir incumplimiento, riesgo y medida inmediata. Asignar corrección, responsable y plazo; mantener estado Pendiente mientras no exista soporte verificable. La reapertura o aprobación exige revisión del resultado, no solo afirmación de cumplimiento.

Seguimiento del estándar

Revisar muestra de registros y observar práctica/recursos. Comparar requisito, evidencia documental y condición real; analizar repetición de fallas y actualizar controles. Conservar acuerdos y permisos auténticos cuando el proceso depende de terceros.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-ORG01 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.